

Nome da Instituição: Fundação José Silveira **Departamento/Setor:** NDEI/ Programa Acolher **Data:** 22 de Abril de 2025 **Autor(es):** Andreza Reis - Trainee de Agilista, **Aprovadores:** Erotildes Santos - Assessora de projetos Sociais; **Palavras-Chave:** Projetos Sociais, Amamentação, Jequié, Guia, Aconselhamento

Título do Documento: Guia resumido para a prática de aconselhamento à amamentação

Introdução:

Conteúdo da Seção: A amamentação é uma das principais estratégias para redução das taxas de mortalidade materna e infantil. Os benefícios da amamentação para a saúde do bebê e da mãe prolongam-se pela vida adulta e contribuem para a sustentabilidade da sociedade, no sentido econômico e ambiental, em contraponto a fórmulas infantis. Apesar disso, o ato de amamentar, ao contrário do que social e culturalmente se propaga, não ocorre apenas de forma espontânea, linear e “natural”, levando em consideração que existem interferências do meio. A Fundação José Silveira, tendo por missão cuidar da saúde e promover ação social com excelência em benefício da sociedade, investiu na qualificação de profissionais para atuarem como Conselheiras(os) Comunitárias(os) Promotores da Amamentação. Acreditamos que a presença das(os) conselheiras(os) nas comunidades, oferecendo apoio, orientação e escuta às mulheres que amamentam e aos seus familiares, poderá contribuir de forma significativa e decisiva para a prevenção do desmame precoce e, por conseguinte, redução das taxas de mortalidade materna e infantil. A publicação do guia nasce com o objetivo de ser mais um recurso de suporte para o fundamental trabalho social desenvolvido por esses profissionais.

O guia funciona como um material de consulta, criado para auxiliar, de maneira rápida, as(os) conselheiras(os) em caso de dúvidas. Ele é fruto da formação realizada no grupo e permeia os principais cuidados sobre a amamentação, dividido em dois grandes tópicos:

- A. Escuta e empatia, que aborda sobre Amamentação e sociedade, amamentação e desenvolvimento infantil, construindo vínculos: comunicação e confiança e ética em saúde.
- B. Apoio, técnicas e cuidados que versa sobre Como o leite materno chega até o bebê, anatomia da mama, tipos de mamilo, fisiologia da lactação, como amamentar, posições para amamentar, pega adequada ou pega correta, como colocar o bebê no peito, quando oferecer o peito, sinais de fome ou saciedade, como terminar a mamada, extração manual do leite, por que retirar o leite das mamas, quando retirar o leite das mamas, como conservar o leite materno, como fazer a extração manual do leite materno, intercorrências mamárias: principais dificuldades na amamentação, aleitamento em condições especiais, nova gravidez, gemelaridade, crianças com

malformações orofaciais, crianças portadoras de distúrbios neurológicos, mitos e tabus sobre a amamentação, cuidados com a saúde da mulher e rede de apoio.

Seção 1: Histórico

- **Conteúdo da Seção:** *O projeto Conselheiras(os) Comunitárias(os) Promotoras(es) da Amamentação está sendo implementado pela Fundação José Silveira na unidade Santa Casa Hospital São Judas Tadeu (HSJT), maternidade com atendimento integral pelo SUS, localizada na cidade de Jequié, Bahia, que é referência para assistência à gestação de alto risco para 26 municípios da microrregião.*

A maternidade HSJT, como parte de suas ações para integração à Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), e em reconhecimento da relevância do trabalho social que será desenvolvido pelas(os) Conselheiras(os) em Amamentação, realizou a formação do primeiro time das(os) Conselheiras(os) Comunitárias(os) Promotoras(es) da Amamentação, com a participação de 25 profissionais.

A preparação das(os) Conselheiras(os) teve início com a participação em uma capacitação realizada pela Fundação José Silveira, em parceria com a Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), com a presença de profissionais especialistas em Aleitamento Materno.

Cientes da importância da continuidade do processo formativo desses profissionais, foram realizadas oficinas e encontros de acompanhamento das(os) Conselheiras(os) com os especialistas, para suporte e orientação a esses profissionais ao longo do desenvolvimento de seus trabalhos. Faz parte da ação, ainda, o monitoramento das mães e bebês assistidos pelo projeto para a identificação de demandas, avanços, conquistas e pontos de melhoria da intervenção.

Com o estudo do Guia para a prática de aconselhamento à amamentação, as Conselheiras em Amamentação iniciam as visitas domiciliares às mulheres que estão amamentando.

- **Unidades envolvidas?:** *Maternidade HSJT, PSC Jequié, PSC Salvador.*

Seção 2: Depoimentos

- **Conteúdo da Seção:** *“O Guia Conselheiros Comunitários Promotores em Amamentação tem um caráter muito especial, pois nasce de uma proposta de extensão das atividades desenvolvidas pela Maternidade Santa Casa Hospital São Judas Tadeu. A Fundação José Silveira está materializando o passo 10 da Iniciativa Hospital Amigo da Criança e da Mãe, que é de estimular a comunidade a apoiar e incentivar o aleitamento materno. Contar com pessoas na comunidade que possam prestar auxílio adequado e com suporte, vinculado à maternidade, tem um valor imenso, uma vez que pode ser evitado o desmame precoce, além de gastos financeiros indevidos, e prevenir doenças.” - Dra. Dolores Fernandez Fernandez.*

- *“Devemos dar total apoio às mães e orientações sobre a importância da amamentação nos seis primeiros meses de vida do bebê.” - Rozilene Silva*
- *“O conhecimento sobre a amamentação nos ajuda a colaborar e alcançar o propósito da Fundação José Silveira.” - Mateus Batista*
- *“Algumas mães, por falta de experiência e muito trabalho, não amamentam seus bebês. As Conselheiras de Amamentação podem apoiá-las.” - Antonia Lima.*
- *“Quero fazer esse trabalho com muita dedicação, dar o melhor de mim para a amamentação.” - Maria Raimunda Nascimento.*
- *“Quero aprender, orientar e motivar as mães para que elas promovam as mudanças que podem transformar suas vidas.” - Valdirene Matos*
- *“Aprender e ensinar sobre a importância da amamentação para a vida das crianças.” - Rosana Reis*
- *“Passar o melhor para que as mães se sintam acolhidas nessa fase de suas vidas.” - Juliana Silva*
- *“Realizar um trabalho com qualidade para fortalecer as ações em prol do aleitamento materno.” - Ana Regina Rocha*
- *“Conhecer, estar perto de cada gestante, para poder orientá-la.” - Geison Dias*

Seção 3: Amamentação e sociedade

- **Conteúdo da Seção:** Esse conteúdo pode ser encontrado a partir da página 13 do guia completo.
- *Por que é importante amamentar? Porque faz bem para a saúde da criança e da mulher. Porque promove e fortalece o vínculo afetivo. Porque é econômico. Porque faz bem para a sociedade. Porque é um ato de promoção da saúde e preservação da vida. Porque faz bem para o planeta.*
- *Alguns fatores sociais que podem contribuir para o desmame precoce e, consequentemente, para o aumento das taxas de mortalidade materna e infantil, são:*
 - *A necessidade de breve retorno ao trabalho – seja o trabalho realizado no mercado formal, o trabalho informal realizado fora do lar ou mesmo dentro do lar;*
 - *o incentivo ao consumo de leites e fórmulas infantis em substituição ao leite materno, promovido pelo marketing agressivo das empresas produtoras de fórmulas de leites infantis;*
 - *a falta de fiscalização por parte do poder público para o cumprimento da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância (NBCAL);*
 - *a falta de políticas públicas específicas para responder às necessidades da mulher que amamenta.*
- *A amamentação pode contribuir para o alcance dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU. São eles:*

- *Erradicação da pobreza: Considera o efeito da amamentação na inteligência e no capital humano;*
- *Promoção da nutrição: A amamentação como recurso para o combate à desnutrição infantil;*
- *Saúde e bem estar: A amamentação é um agente para a promoção da saúde materna e infantil, que se estende para a vida adulta, contribui para a prevenção de doenças não transmissíveis, tais como câncer de mama e diabetes, bem como sobrepeso e obesidade;*
- *Educação de qualidade: Considera o efeito da amamentação na inteligência e no capital humano;*
- *Crescimento econômico inclusivo: Considera o efeito da amamentação na inteligência e no capital humano como potencializador do crescimento econômico inclusivo;*
- *Redução de desigualdades: Os impactos sociais da amamentação, em longo prazo, podem ajudar a diminuir a distância entre ricos e pobres.*

Seção 4: Amamentação e desenvolvimento infantil

- **Conteúdo da Seção:** *Esse conteúdo pode ser encontrado a partir da página 16 do guia completo. Nos seis primeiros meses após o nascimento, a criança está desenvolvendo e amadurecendo várias áreas importantes para sua existência, e o leite materno possui diversos nutrientes, vitaminas, minerais, proteínas, gorduras, carboidratos e anticorpos³ que, juntos, trabalham de forma vital para garantir o desenvolvimento saudável e completo do ser humano nesta fase da vida. É por isso que o aleitamento materno exclusivo é recomendado até os seis meses de vida. **Com a amamentação exclusiva, não é necessário nem água⁴ para a nutrição do bebê.** Veja como ele atua na prática:*
- **Desenvolvimento físico (biológico):**
 - *fortalecimento do sistema neuromotor;*
 - *fortalecimento do sistema imunológico;*
 - *fortalecimento do sistema respiratório;*
 - *amadurecimento das funções de sugar, mastigar, engolir, falar e respirar;*
 - *promoção do peso ideal, prevenindo a obesidade;*
 - *prevenção contra doenças cardíacas, contagiosas e alérgicas;*
 - *alívio de cólicas.*
- **Desenvolvimento cognitivo (intelectual):**
 - *amadurecimento do sistema cognitivo, contribuindo para o desenvolvimento intelectual.*
- **Desenvolvimento emocional (psicossocial):**
 - *auxílio na relação afetiva entre mãe e filho;*
 - *fortalecimento do sistema psicológico, para que a criança se sinta segura, contente e madura para que possa: com até 4 meses, sorrir para as expressões de um rosto, ou mexer as pernas, braços e barriga; com até 8 meses, estender os braços quando quer ser abraçado; com até 12 meses, diante de uma*

situação de estresse, ficar bem, dentro de curto espaço de tempo; com até 18 meses, pedir ajuda aos pais para brincar ou comer; ir até a geladeira para mostrar a comida que quer; de 1 a 2 anos, usar frases como “me abraça” e “eu quero”, além de demonstrar raiva ou “birra”, mas ficar bem após um período.

Seção 5: Construindo vínculos: comunicação e confiança

- **Conteúdo da Seção:** *Esse conteúdo pode ser encontrado a partir da página 18 do guia completo. A escuta e o diálogo são habilidades de comunicação essenciais para a construção de relações de confiança e fortalecimento de vínculos. Reconhecemos ser importante que a(o) Conselheira(o) dedique especial atenção ao uso de falas, expressões, atitudes e comportamentos que contribuam para que a mãe se sinta acolhida com a sua presença e possa abrir-se para a construção do vínculo e da confiança necessários para o exercício do aconselhamento.*
- *Durante sua atuação, as(os) Conselheiras(os) podem utilizar das suas habilidades de comunicação para:*
 - *ouvir e aprender sobre as crenças da mulher, seu nível de conhecimento e suas práticas;*
 - *aumentar sua confiança e elogiar práticas que deseja encorajar; fornecer informações;*
 - *comunicar-se com familiares que influenciam a mãe, especialmente aqueles que sejam capazes de influenciar de forma negativa as práticas de alimentação do bebê;*
 - *sugerir mudanças que a mulher possa acolher a fim de melhorar seu amamentar;*
 - *combinar visitas de acompanhamento.*
- *Formas de comunicação não verbal com as mães*
 - *Sentar-se no mesmo nível e próximo à mãe;*
 - *Remover barreiras físicas como mesas ou pastas de papel que se tem nas mãos;*
 - *Prestar atenção à mãe, evitar se distrair e mostrar que está ouvindo, afirmando com a cabeça, sorrindo ou fazendo outros gestos adequados;*
 - *Não apressar a conversa e não olhar para o relógio. Só tocar na mãe de forma apropriada (como na mão ou no braço);*
 - *Não tocar em suas mamas ou em seu bebê sem sua permissão.*
- *Formas de comunicação verbal com as mães:*
 - *Estimular a mãe a falar: demonstrar interesse e devolver em outras palavras ou com gestos o que você compreendeu sobre o que a mãe falou;*
 - *Fazer perguntas abertas: perguntas iniciadas com “Quando?”, “Como?”, “Onde?”, “Por quê?”, podem estimular a mãe a conversar com você;*
 - *Demonstrar que se compreende o que ela diz;*

- *Evitar perguntas fechadas: perguntas iniciadas com “Você está?”, “Você fez?”, “O bebê já?”, podem ser respondidas com sim ou não e podem não oferecer muitas informações;*
- *Evitar fazer muitas perguntas, mas estimular que a mãe se sinta confortável e segura para falar.*
- *É possível apoiar as puérperas da seguinte forma:*
 - *Sendo empático: A empatia acontece quando demonstramos que estamos ouvindo o que a mãe diz e tentando entender como ela se sente; quando acolhemos o ponto de vista da mãe, sem julgamentos;*
 - *Aceitando o que a mãe pensa e sente: Podemos aceitar as ideias e sentimentos da mãe sem discordar dela, isso não é o mesmo de concordar com ela. Você pode aceitar o que ela diz e, em outro momento, fornecer a informação correta. Aceitar o que ela diz ajuda a mãe a confiar em você e a encoraja a continuar a conversa, porque sente que foi escutada;*
 - *Reconhecendo os avanços: Reconheça e elogie o que a mãe e o bebê conseguiram realizar;*
 - *Oferecendo ajuda prática: Observe se a mãe está confortável, em posição relaxada, se está com sede ou fome, ou se tem outras necessidades, e ofereça apoio e ajuda prática para que ela consiga se concentrar melhor no bebê;*
 - *Fornecendo informações com linguagem simples: Dedique atenção ao que a mãe precisa saber naquele momento, com uso de palavras adequadas, que a mãe entenda, e sem exagerar na quantidade de informações;*
 - *Não dando ordens, mas oferecendo sugestões: Não diga à mãe o que ela deve ou não fazer; ofereça escolhas e deixe que ela decida o que é melhor para ela.*

Seção 6: Ética em saúde

- **Conteúdo da Seção:** *Esse conteúdo pode ser encontrado a partir da página 21 do guia completo. A palavra “ética” vem do grego ethos, que significa “caráter”, “costume”. Pode ser definida como um conjunto de padrões, normas e valores morais que orientam o comportamento de um grupo ou indivíduo. A ética é uma área da filosofia moral que é dedicada às ações e comportamentos humanos.*
- **Somos éticos quando:**
 - *defendemos para todos os seres humanos um tratamento respeitoso;*
 - *compreendemos o nosso dever de respeitar os interesses de todos;*
 - *ampliamos nossa defesa pelo que é coletivo;*
 - *defendemos os interesses de todos da sociedade na qual estamos inseridos;*
 - *buscamos agir pelo princípio da igualdade, sendo a decência e a coerência moral fundamentais.*
- *E a ética do profissional em saúde, o que é? É a missão de cuidar da saúde da população. Para isso, precisamos exercitar nossa consciência crítica, avaliar nossa prática e as consequências do nosso comportamento nas relações com a população (mãe, pai, família), com o colega de todas as profissões e com os meios de trabalho.*
- **Passos para a atuação ética da(o) Conselheira(o) da Amamentação:**

- 1º passo – Preparar-se para a entrevista
 - Perceber as questões das pessoas envolvidas no acompanhamento;
 - sempre perguntar os motivos que levam as pessoas a tomar as suas decisões;
 - perguntar sobre os temores e medos que possam ter em relação à amamentação;
 - perceber o outro como ele é: suas questões, seus motivos, seus medos e anseios;
 - sempre anotar as observações das suas ações;
 - sempre orientar o que diz a ciência, e não o que você pensa;
 - compreender o que a pessoa é contrária, respeitando as suas posições, mas sempre alertando sobre as orientações da ciência.
- 2º passo – Saber conversar
 - Ter objetivos determinados;
 - ter as ferramentas para a entrevista, quando necessário;
 - acolher a pessoa, o momento em que ela vive;
 - propor, em vez de impor;
 - criar confiança mútua; partilhar o cuidado;
 - respeitar a autonomia; caminhar juntos!
- 3º passo - Saber fazer perguntas
 - Fazer perguntas que proporcionem respostas efetivas;
 - não ferir ou causar atropelos;
 - não ser desconcertante; não irritar a pessoa;
 - não causar desconfiança;
 - não causar desconforto.
- 4º passo - O caminho do entrevistador
 - Ter objetividade; ter precisão no que diz;
 - ter respeito pelo outro; ser sincero;
 - ter um genuíno interesse pela situação que a mãe ou a família esteja vivendo;
 - ter empatia.

Seção 7: Como o leite materno chega até o bebê?

- **Conteúdo da Seção:** Esse conteúdo pode ser encontrado a partir da página 28 do guia completo. A mama é formada por diferentes partes, e cada uma delas tem função importante, ainda no período da gestação, para a produção do leite. A área mais escura ao redor do mamilo é chamada de aréola. Nela, ocorre a produção de secreções importantes para manter a pele dessa região saudável e para a produção do cheiro da mãe, essencial para que o bebê a reconheça e encontre a mama.⁶ Para uma boa mamada, o bebê precisa estar com a boca bem aberta. A mãe deve colocar parte da boca na aréola, a língua sobre a gengiva inferior, aproximar o bebê ao peito com o mamilo apontando para o céu da boca e o queixo encostado na mama. Todas as mamas são boas para amamentar. Então, é importante deixar claro para as mães

que a quantidade de leite produzida não tem relação com o tamanho ou a forma da mama das mulheres. Entendendo isso, busque tranquilizar a mãe, informando que nenhum tipo de mamilo impede a amamentação. Entretanto, alguns podem apresentar dificuldade no início do processo, mas, com apoio e orientações assertivas sobre o posicionamento para amamentar e a pega correta, esses desafios podem ser contornados.

- O leite é produzido pelas células que recebem nutrientes levados pelos vasos sanguíneos localizados ao redor dos alvéolos. Esse leite é expelido da mama pela contração dos músculos que também estão ao redor de cada alvéolo.⁶ O colostro é o leite que a mulher produz nos primeiros dias após o nascimento do bebê, mas, para a produção e fluxo do leite materno, é importante a presença de dois hormônios que atuam após o parto: a prolactina e a ocitocina. A ocitocina pode deixar a mãe sonolenta e relaxada. No entanto, pode ser temporariamente inibida, caso a mãe esteja em situação de dor extrema (mamilos fissurados, pontos de parto cesariano ou episiotomia), estresse de qualquer causa, dúvidas, vergonha ou ansiedade, ou ainda por uso de nicotina (fumo) e álcool ¹¹. É necessário ter atenção à presença de alguns fatores que podem inibir, interromper, a produção do leite materno, tais como⁶:
 - quando o bebê mama apenas de um lado, o leite pode ser produzido em uma mama, mas não na outra. Isso ocorre porque o leite contém um inibidor que pode reduzir a sua própria produção;
 - deve-se alternar as mamas durante a mamada; se a mama estiver cheia e o leite não for retirado, pode ocorrer a redução da produção do leite;
 - se o leite for retirado da mama, a produção de leite aumenta; a pega da mama inadequada; mamadas com intervalos longos; interromper ou interferir no tempo de mamada desejado pelo bebê pode interferir na produção do leite materno.

Seção 8: Como amamentar?

- **Conteúdo da Seção:** Esse conteúdo pode ser encontrado a partir da página 33 do guia completo. Posições para amamentar: Um conhecimento importante para a atuação das(os) Conselheiras(os) é sobre as posições adequadas para a amamentação. São detalhes que podem parecer insignificantes, mas não são. Tanto a mãe quanto o bebê precisam estar em posições adequadas e confortáveis para que o amamentar flua sem dificuldades.
 - **Mulher sentada tradicional:** Mulher sentada, com o bebê bem junto ao colo, com o corpo do bebê virado para o corpo da mãe e bem apoiado pelo braço do mesmo lado da mama que está sendo oferecida (posição tradicional). Útil para ajudar a drenar todas as regiões da mama. Oferece à mãe uma boa visão da pega da mama pelo bebê. Cuide para que o bebê não dobre o pescoço forçando o queixo contra o peito. Verificar imagem dessa posição na página 34 do guia das conselheiras.
 - **Mulher sentada invertida tradicional:** Mulher sentada, apoiando a criança com o braço oposto ao da mama que está sendo oferecida (posição

tradicional invertida). Verificar imagem dessa posição na página 34 do guia das conselheiras.

- *Mulher sentada cavaleiro: Mulher sentada, com o bebê apoiado ao seu corpo verticalmente (posição de cavaleiro). Verificar imagem dessa posição na página 34 do guia das conselheiras.*
- *Mulher sentada ninho: O bebê fica posicionado na sua lateral (posição de jogador de futebol americano). A parte inferior do braço do bebê passa pela lateral do corpo da mãe. Não fica entre o peito do bebê e da mãe. Preste atenção para que a cabeça do bebê não fique muito perto da axila da mãe, para que a mama não seja puxada para o lado dificultando a pega da mama pelo bebê. Posição indicada para amamentar bebês prematuros, muito pequenos. Verificar imagem dessa posição na página 35 do guia das conselheiras.*
- *Mulher sentada com braço cruzado: Útil para bebês pequenos ou doentes. A mãe tem bom controle sobre a cabeça e o corpo do bebê, portanto, funciona quando ela está aprendendo a amamentar. Preste atenção para a mãe não segurar a cabeça do bebê com muita firmeza, impedindo a movimentação. Verificar imagem dessa posição na página 35 do guia das conselheiras.*
- *Mulher deitada junto ao bebê: A mãe deve deitar-se de lado, apoiando sua cabeça e costas em travesseiros para ficar mais à vontade. A mãe também pode dar de mamar recostada na cama. Com um braço, a mãe apoia o pescoço e o tronco do bebê, ajudando a aproximar o corpo do bebê ao seu corpo, e com a outra mão aproxima a boca do bebê do bico do peito. Ele próprio vai procurar o bico. Ajuda a mãe a descansar. Confortável após o parto cesariano. Prestar atenção para que o nariz do bebê esteja no nível do mamilo da mãe e para que o bebê não precise dobrar o pescoço para alcançar a mama. Verificar imagem dessa posição na página 35 do guia das conselheiras.*
- *Pega adequada ou pega correta: Pega é o nome dado ao encaixe da boca da criança ao peito da mãe para poder mamar. É recomendado apoiar a mama com a mão em forma de “C” para colocar o peito na boca da criança. Uma pega adequada favorece a retirada eficiente do leite da mãe pela criança e não machuca a mulher. Verificar imagem da pega correta nas páginas 36 e 37 do guia das conselheiras. Existem alguns sinais que indicam pega favorável, são eles:*
 - *boca bem aberta;*
 - *lábios virados para fora (boca de peixinho);*
 - *queixo encostado na mama;*
 - *ver a aréola (a parte escura da mama em volta do mamilo) aparecer mais acima do que abaixo da boca do bebê.*
- *Dicas para que o bebê tenha uma pega adequada:4*
 - *estimular o reflexo de busca;*
 - *tocar a boca do bebê com o mamilo;*
 - *esperar que o bebê esteja com a boca bem aberta (como se fosse bocejar);*
 - *aproximá-lo da mama, e não a levar até ele;*

- *remover qualquer obstáculo entre a boca da criança e a parte da mama que a criança precisa abocanhar (mamilo e parte da aréola – parte mais escura do peito), como roupas, panos, mãos ou dedos da mãe;*
- *o rosto da criança deve estar próximo e de frente para a mama e com o nariz na frente do bico do peito (mamilo);*
- *colocar a criança no peito para sugar quando ela estiver com a boca bem aberta.*
- *Sinais de sucção eficaz ou eficiente:*
 - *O bebê suga lentamente e profundamente.*
 - *É possível ver e ouvir o bebê engolindo.*
 - *As bochechas do bebê ficam arredondadas durante a mamada.*
 - *O bebê termina a mamada e solta a mama sozinho e parece satisfeito.*
- *Sinais de sucção não eficaz ou ineficiente:*
 - *Suga a intervalos curtos.*
 - *Emite sons de estalido com a boca.*
 - *Tem as bochechas encovadas.*
 - *Está inquieto e parece insatisfeito na mama, e a solta com frequência.*
 - *Mama com intervalos muito curtos.*
 - *Não está satisfeito ao fim da mamada.*
- *A pega inadequada pode gerar consequências para a saúde da mãe e do bebê. Por isso, ao observar o início de algum dos sinais abaixo, devemos buscar os recursos e apoio necessários para evitar a evolução da situação: Mamilos doloridos; Mamilos feridos (fissuras); Ingurgitamento; Bebê insatisfeito e chora muito; O bebê mama com frequência e por muito tempo; Bebê frustrado, dificuldade para mamar; Diminuição da produção de leite; Bebê não consegue ganhar peso; Esvaziamento da mama insuficiente; Mãe insegura, se sente falhando e para de amamentar.*
- *É importante destacar que todas as mães precisam de ajuda para posicionar seu bebê. Enquanto Conselheiras(os), devemos nos colocar à disposição da mãe para apoiá-la nesse momento. Também podemos orientar os(as) companheiros(as) e familiares da mãe para que eles possam dar suporte no posicionamento da mulher e do bebê para amamentar.*
 - *O corpo do bebê deve estar inteiramente de frente para a mãe e bem próximo (barriga do bebê voltada para a barriga da mãe);*
 - *O bebê deve estar alinhado, a cabeça e a coluna em linha reta, no mesmo eixo; A linha do nariz do bebê deve estar de frente para o mamilo, e este apontando para o céu da boca do bebê;*
 - *A mãe deve apoiar, com o braço e a mão, o corpo e o “bumbum” do bebê;*
 - *Aproximar a boca do bebê bem em frente ao peito, para que ele possa abocanhar, ou seja, colocar a maior parte da aréola (área mais escura e arredondada do peito) dentro da boca;*
 - *O queixo do bebê deve tocar o peito da mãe;*
- *Algumas orientações podem ser dadas à mãe para auxiliá-la no momento de oferecer o peito.¹²:*

- *Para dar de mamar, oriente a mãe a estar calma e não apressar o bebê; observe seu interesse para iniciar e terminar a mamada.*
- *Antes de amamentar, caso o peito esteja muito cheio, oriente a mãe a fazer uma expressão manual para amaciar a aréola. Com os dedos indicador e polegar, ela deve espremer as regiões acima e abaixo do limite da aréola para retirar algumas gotas de leite e amaciar o bico.*
- *Orienta a mãe a levar o bebê ao peito, e não o peito ao bebê, encostando o bico do peito na boca do bebê, para ele virar a cabeça e pegar o peito – reflexo da busca. Ele sozinho sabe como fazer isto.*
- *A mãe precisa segurar o peito com o polegar acima da aréola e o indicador e a palma da mão abaixo, em formato de C, isso facilitará a pega adequada.*
- *O bebê abocanha a maior parte da aréola, o lábio inferior fica voltado para fora, como se fosse uma boquinha de peixe. O nariz fica livre, suga mais leite e evita rachaduras.*
- *A mãe deve ouvir o ritmo do bebê sugando, deglutindo e fazendo pausa para respirar e voltar a sugar novamente.*
- *É preciso respeitar o ritmo de mamar de cada bebê.*
- *Deve-se apoiar o bebê, deixando os seus braços livres.*
- *Uma das principais estratégias para o sucesso da amamentação é identificar e assegurar os momentos adequados para oferecer o peito.¹²:*
 - *Oferecer o peito logo após o nascimento, ainda na sala de parto, quer seja parto normal ou cesárea, porque estimula a produção e descida do leite.*
 - *Oferecer o peito sempre que o bebê quiser, de dia ou de noite, sob livre demanda, porque, quanto mais o bebê mama, mais leite o peito produz.*
 - *Oferecer um peito até o bebê soltar e, depois, oferecer o outro.*
 - *Não interromper a mamada, porque é importante dar de mamar até o bebê soltar, para receber o leite do final da mamada.*
 - *Na mamada seguinte, começar com o peito que o bebê sugou por último na mamada anterior, ou no que não mamou, porque é importante retirar a maior quantidade possível de leite para estimular sua produção.*
 - *ATENÇÃO! Quando percebemos que o bebê suga, mas não engole o leite, então é hora de mudar de mama. Essa é a sucção não nutritiva.*
- *Sinais de fome ou saciedade, É importante lembrar que o choro será sempre o último sinal. Portanto, o bebê deve ser colocado para mamar ainda nos primeiros sinais de fome, ou seja, fome pouca ou com fome:*
 - *Pouca fome: abre a boca; mexe de um lado para outro, estica braços e pernas; procura a mama*
 - *Muita fome: coloca a mão na boca; começa a se mexer mais; se estica todo*
 - *Muita fome! Choro: Choro; pede colo; fica com o rosto avermelhado*
- *Como terminar a mamada:*
 - *Geralmente, o bebê solta sozinho o peito. Mas, se for preciso interromper a mamada, a mãe deve colocar a ponta do dedinho mínimo no canto da boca do bebê para que ele solte o peito sem machucar.*

- *Para o bebê arrotar, a mãe, o pai ou outro familiar deve levantá-lo e apoiar a cabeça no seu ombro e fazer uma leve massagem nas costas. É importante a participação da família neste momento.*
- *Outra posição para arrotar é colocar o bebê sentado no colo da mãe, inclinando-o para a frente, apoiado com o braço da mãe, voltado para a frente com as pernas flexionadas.*
- *O peito não precisa de limpeza antes ou após as mamadas. O banho diário é suficiente.*
- *Lembrar que cada mãe e bebê são únicos e muitas regras podem não combinar. O que vale para uma mãe pode não valer para outra.*

Seção 10: Extração manual do leite

- **Conteúdo da Seção:** *Esse conteúdo pode ser encontrado a partir da página 45 do guia completo. Por que retirar o leite das mamas? Quando as mamas ficam muito cheias, a pega é dificultada e o bebê não retira a quantidade de leite de que necessita. Além disso, o mamilo pode “rachar”, tornando a mamada dolorosa.*
- **Quando retirar o leite das mamas?**
 - *Quando a mãe tem leite em excesso;*
 - *Quando a mãe e o bebê não podem ficar juntos, em situações como: a mãe ou o bebê está doente; a mãe tem problemas de saúde e precisa ficar internada; no lugar onde a mãe trabalha não tem creche; a mãe precisa viajar e não pode levar o filho.*
 - *Quando o bebê tem dificuldade de sugar, o que pode acontecer quando: o bebê nasceu muito antes do tempo e tem pouco peso; tem deformidade na boca; tem dificuldade para respirar; apresenta falta de coordenação para a sucção; ainda está aprendendo a sugar um mamilo invertido.*
 - *Quando a mama estiver cheia, para facilitar a pega.*
 - *Quando a mãe deseja doar o excedente de seu leite, que é usado por crianças que não estão mamando no peito de sua mãe. Atenção! Para que a criança tome leite de outra mãe, é obrigatório pasteurizá-lo previamente num banco de leite humano. Nenhum bebê deve mamar no peito de outra mãe que não seja a sua.*
- **Como conservar o leite materno?**
 - *Se não tiver refrigerador, o leite pode ser coletado em um recipiente limpo e ser oferecido imediatamente.*
 - *O leite ordenhado pode ser refrigerado com segurança por até 12 horas ou congelado por até 15 dias.*
 - *Antes de alimentar o bebê com o leite guardado, é preciso aquecê-lo em banho-maria.*
 - *O leite deve ser oferecido ao bebê com colher, copo ou xícara, e lembrar sempre de jogar fora o que sobrou.*
- **Como fazer a extração manual do leite materno?** *Verificar imagem da extração do leite na página 47 do guia das conselheiras.*

- *A mãe deve lavar bem as mãos;*
- *Prender os cabelos e usar uma touca de banho ou pano amarrado;*
- *Proteger a boca e o nariz com pano ou fralda;*
- *Escolher um lugar limpo e tranquilo;*
- *Preparar uma vasilha (de preferência um frasco de vidro com tampa plástica) fervida por 15 minutos;*
- *Escorrer a água da panela e colocar o frasco e a tampa para secar de boca para baixo em um pano limpo ou papel toalha.*
- *Não enxugar. Deixar secar naturalmente.*
- *Massagear o peito com a ponta de dois dedos iniciando na região mais próxima da aréola, indo até a região mais distante, apoiando o peito com a outra mão;*
- *Massagear a mama de encontro ao tórax, massageando por mais tempo as áreas mais doloridas;*
- *Apoiar a ponta dos dedos (polegar e indicador) acima e abaixo da aréola, apertar suavemente um dedo contra o outro, sem deslizá-los na aréola, repetindo o movimento até o leite começar a sair;*
- *Não pressionar demais, pois pode bloquear os canais por onde passa o leite.*
- *No primeiro momento, o leite pode não sair, mas, depois de pressionar algumas vezes, começará a pingar.*
- **O QUE NÃO PODE NA EXTRAÇÃO MANUAL DO LEITE:** *Espremer o mamilo; Deslizar os dedos sobre a mama; Puxar ou esticar o mamilo*

Seção 11: Intercorrências mamárias: principais dificuldades na amamentação

- **Conteúdo da Seção:** *Esse conteúdo pode ser encontrado a partir da página 48 do guia completo.*
- **Dificuldade de amamentação: Demora na descida do leite**
 - *Principais sintomas: Leite não desce logo após o parto.*
 - *Principais causas: Em algumas mulheres, a “descida do leite” ou apojadura só ocorre alguns dias após o parto.*
 - *O que pode ser feito: É fundamental que a mulher se sinta confiante e conte com suporte da família e da sua rede de apoio quanto à amamentação. Além disso, o estímulo da mama com sucção frequente contribui para a descida do leite e com o ajuste da produção para as necessidades do bebê. O apoio profissional também é fundamental.*
- **Dificuldade de amamentação: Criança com dificuldade inicial para sugar**
 - *Principais sintomas: Resistência do bebê às tentativas de ser amamentado; com frequência, não se descobre a causa dessa resistência inicial. Presença de dor quando o bebê é posicionado para mamar ou pressão na cabeça do bebê ao ser apoiado.*
 - *Principais causas: Algumas vezes pode estar associada ao uso de bicos artificiais ou chupetas. Pega ou posição inadequada. O bebê pode não*

abocanhar adequadamente a mama porque elas estão muito tensas, ingurgitadas, ou os mamilos são invertidos ou muito planos.

- *O que pode ser feito: Acalmar a mãe e o bebê. Suspender o uso de bicos de mamadeiras, silicone e chupetas. Utilizar apoio para mamas muito grandes. Melhorar a pega e variar a posição do bebê no momento de amamentar. Fazer a retirada do leite do peito com as mãos ou com bomba enquanto o bebê não conseguir sugar a mama para oferecer o leite ao bebê no copo ou colher e para estimular a mama a produzir leite.*
- *Dificuldade de amamentação: Mamilo invertido*
 - *Principais sintomas: Anatomia natural da mama da mulher. Complicações de cirurgia de mama. Câncer de mama.*
 - *Principais causas: A maioria dos mamilos se projeta para fora, mas alguns se retraem ou baixam para dentro, criando uma covinha na extremidade, chamado de mamilo invertido.*
 - *O que pode ser feito: Promover a confiança e empoderar a mãe. Ajudar o bebê a abocanhar o mamilo e a aréola e tentar diferentes posições para facilitar a pega. Se a mama estiver muito cheia, retirar um pouco de leite para a aréola ficar mais macia antes de colocar o bebê no peito, facilitando a pega. Mostrar à mãe manobras que podem ajudar a aumentar o mamilo antes das mamadas, como simples estímulo (toque) do mamilo, compressas frias nos mamilos e sucção com bomba manual ou seringa de 20 mL adaptada (cortada para eliminar a saída estreita e com o êmbolo inserido na extremidade cortada). Recomenda-se essa técnica antes das mamadas e nos intervalos se assim a mãe o desejar. O mamilo deve ser mantido em sucção por 30 a 60 segundos, ou menos, se houver desconforto. A sucção não deve ser muito vigorosa para não causar dor ou mesmo machucar os mamilos. Orientar a mãe a realizar a extração manual do seu leite enquanto o bebê não sugar efetivamente – isso ajuda a manter a produção do leite e deixa as mamas macias, facilitando a pega; o leite ordenhado deve ser oferecido ao bebê, de preferência, em copinho.*
- *Dificuldade de amamentação: Mamilos doloridos e/ou machucados*
 - *Principais sintomas: Hematomas na parte inferior da aréola. Vaso sanguíneo dilatado.*
 - *Principais causas: Pega incorreta.*
 - *O que pode ser feito: O ideal para evitar machucar os mamilos é ajudar o bebê a ter uma pega adequada e, enquanto estiverem machucados, variar a posição das mamadas, iniciar a amamentação na mama não machucada ou menos machucada e enxaguar os mamilos com água limpa, pelo menos uma vez por dia, para evitar infecções. Trocar sutiã para os mamilos quando estiverem molhados. Não usar cremes, pomadas, óleos, leite materno ou qualquer outra coisa para cicatrizar o peito.*
- *Dificuldade de amamentação: Ingurgitamento mamário ou “leite empedrado”*

- *Principais sintomas: Mama dolorosa e edematosa. Mama apertada, especialmente o mamilo, brilhante. Vermelhidão. Leite não flui. Pode ter febre.*
- *Principais causas: Muito leite. Atraso no início da amamentação. Pega incorreta – leite não é removido. Remoção do leite pouco frequente – não amamenta à noite e mamadas curtas. Restrição do tempo de amamentação.*
- *O que pode ser feito: Começar a amamentar logo após o parto. Garantir uma boa pega: segure o bebê pele a pele, ajude na pega e deixe mamar com frequência. Isso estimula a ocitocina. Deixar o bebê mamar sempre que quiser. Fazer massagem com suaves movimentos circulares nas mamas e retirar um pouco do leite antes de colocar o bebê para mamar, facilitando a pega. Antes da alimentação do bebê: Compressas mornas ou banho morno; Massagem no pescoço e nas costas; Massagem leve do peito; Estimular a pele do mamilo; Ajudar a mãe a relaxar; Após a alimentação: compressa fria para reduzir o edema; Usar sutiã de alças largas e firmes para maior conforto.*
- *Dificuldade de amamentação: Fissura*
 - *Principais sintomas: Rachaduras ou fissuras no mamilo. Dor, especialmente quando o bebê abocanha a mama.*
 - *Principais causas: Posicionamento ou pega incorreta.*
 - *O que pode ser feito: Posicionar o bebê corretamente. Corrigir a pega. Manter as mamas enxutas. Evitar mamas muito cheias ou doloridas. Não usar produtos nas mamas. Cuidados com protetor de mamilos. Passar o próprio leite. Expressão manual do leite. Começar a amamentar pela mama menos afetada.*
- *Dificuldade de amamentação: Mastite (inflamação da mama) Mastite com abscesso*
 - *Principais sintomas: A mulher tem dores fortes, febre e, muitas vezes, se sente mal, com dor de cabeça e náuseas. Parte da mama está inchada e dura, com vermelhidão da pele sobrejacente. As outras partes da mama parecem normais. A área vermelha está claramente marcada e é cercada por tecido mamário normal.*
 - *Principais causas: Permanência de leite represado em dutos mamários por prolongado tempo. Pega incorreta. Uso de mamadeiras, bicos ou chupetas que podem causar fissuras mamilares.*
 - *O que pode ser feito Procurar imediatamente um serviço de saúde. A amamentação não precisa ser interrompida durante o tratamento. Os profissionais de saúde e as mães precisam aprender a reconhecer os dutos bloqueados e a mastite em um estágio inicial, antes de progredir para essa gravidade. Além de antibióticos: ela precisa de repouso absoluto – descansar com o bebê é uma boa maneira de aumentar a frequência das mamadas, para melhorar a drenagem; deve continuar com mamadas frequentes, massagens e compressas mornas; incentive-a a comer bem e beber líquidos; lembre-se de que a parte mais importante do tratamento é a retirada do leite da mama.*
- *Dificuldade de amamentação: Bloqueio de dutos lactíferos (leite retido em alguns canais da mama)*

- *Principais sintomas: Nódulo doloroso do tamanho de uma ervilha ou maior ocasionalmente, apresenta-se com uma pequena bolha branca no mamilo.*
- *Principais causas: Amamentações infrequentes ou curtas. Remoção ineficiente de leite de parte ou de toda a mama: sucção ineficaz; pressão das roupas; pressão dos dedos durante as mamadas; mama grande drenando mal. Tecido mamário danificado (traumas na mama – mastite). Entrada de bactérias (fissura do mamilo). Uso de cremes que obstruem o mamilo.*
- *O que pode ser feito: Amamentar com frequência, massagear a área afetada, esvaziar as mamas, amamentar em diferentes posições e oferecer primeiramente a mama com o problema, com o queixo do bebê direcionado para a área afetada. Se algum destes sintomas persistir – sintomas graves (febre alta, grande área afetada), fissura – e não houver melhora em 24 horas, encaminhar para o médico.*
- *Dificuldade de amamentação: Candidíase (monilíase)*
 - *Principais sintomas: Coceira, sensação de queimadura e dor em agulhadas nos mamilos, que persiste após as mamadas. A pele dos mamilos e da aréola pode apresentar-se avermelhada, brilhante ou apenas irritada ou com fina descamação. Raramente se observam placas esbranquiçadas. Algumas mães queixam-se de ardência e dor em agulhada dentro das mamas. É muito comum a criança apresentar crostas brancas orais, que devem ser distinguidas das crostas de leite (essas últimas são removidas sem machucar a língua ou gengivas).*
 - *Principais causas: São fatores predisponentes a umidade e lesão dos mamilos e uso, pela mulher, de antibióticos, contraceptivos orais e esteroides. Na maioria das vezes, é a criança quem transmite o fungo, mesmo quando a doença não seja aparente.*
 - *O que pode ser feito: Mãe e bebê devem ser tratados simultaneamente, mesmo que a criança não apresente sinais evidentes de candidíase. Enxaguar os mamilos e secá-los ao ar livre após as mamadas e expô-los à luz por pelo menos alguns minutos ao dia. As chupetas e bicos de mamadeira são fontes de reinfecção, por isso, caso não seja possível eliminá-los, eles devem ser fervidos por 20 minutos pelo menos uma vez ao dia. Tratamento tópico de acordo com orientação médica*
- *Dificuldade de amamentação: Hiperlactação (excesso de leite)*
 - *Principais sintomas: Mamas quentes. Mamas pesadas. Mamas duras. Leite fluindo. Mulher sem febre.*
 - *Principais causas: Hiperestímulos. Questões hormonais ou fisiológicas.*
 - *O que pode ser feito: Evitar retirar leite das mamas antes das mamadas e só fazer isso quando elas estiverem muito cheias, causando desconforto, ou se os mamilos estiverem cheios, dificultando a pega do bebê. Amamentar em apenas uma mama a cada mamada, retirando um pouco de leite da mama não usada, apenas para o conforto da mulher. Amamentar em uma posição mais deitada ou de lado, pois nessas posições o fluxo de leite*
- *Dificuldade de amamentação: “Pouco leite”*

- *Principais sintomas: “Redução” da produção do leite.*
- *Principais causas: Na maioria das vezes, essa percepção é o reflexo da insegurança materna quanto à sua capacidade de nutrir plenamente o seu bebê. Pressão da família diante do choro do bebê. Se introduzida a suplementação, a criança passa a sugar menos o peito e, como consequência, vai haver menor produção de leite. É o número de vezes que a criança mama ao dia e a sua capacidade de esvaziar com eficiência a mama que vão determinar o quanto de leite materno é produzido.*
- *O que pode ser feito: Procurar um ambiente mais tranquilo e confortável para amamentar. Melhorar o posicionamento e a pega, se necessário; aumentar a frequência das mamadas, inclusive durante a noite; oferecer as duas mamas quando for amamentar, deixando o bebê esvaziar primeiro uma para depois oferecer a outra. Massagear a mama durante as mamadas; dar tempo para o bebê mamar bastante em um dos peitos antes de trocar para o outro. Retirar manualmente ou com bomba o leite que fica na mama após as mamadas. Evitar o uso de mamadeiras, chupetas e bicos de silicone. Ingerir água em quantidade suficiente para matar a sede. Consumir dieta saudável; repousar sempre que possível.*

Seção 12: Aleitamento em condições especiais

- **Conteúdo da Seção:** *Esse conteúdo pode ser encontrado a partir da página 54 do guia completo. Existem situações especiais, devido a alguma necessidade da mãe ou da criança, em que a amamentação pode ser promovida, requerendo, porém, atenção às condições particulares em que a dupla está envolvida, para a identificação do apoio e suporte adequados para que o aleitamento seja garantido.¹¹*
- **Nova gravidez:** *Diante de uma nova gravidez, se a mãe desejar continuar amamentando o filho mais velho, após o nascimento do bebê, isso é possível. No entanto, é importante orientar que ela deve dar prioridade à criança mais nova. Na ameaça de parto prematuro, é indicado interromper a lactação do filho mais velho. Nesses casos, é comum observar:*
 - *crianças interromperem a amamentação de forma espontânea quando a mãe engravida;*
 - *o desmame pode ocorrer pela diminuição da produção de leite ou alteração no gosto do leite (mais salgado, por maior conteúdo de sódio e menor concentração de lactose);*
 - *perda do espaço destinado ao colo com o avanço da gravidez;*
 - *aumento da sensibilidade dos mamilos durante a gravidez e fadiga materna, pelas alterações hormonais que costumam causar sonolência.*
- **Gemelaridade:** *É possível uma mãe amamentar dois ou mais bebês, já que as mamas são capazes de responder às necessidades nutricionais de cada criança. De acordo com o imaginário coletivo, há uma preocupação a respeito de se a mãe conseguirá produzir leite suficiente para duas crianças, mas, vale lembrar que, quanto mais a criança suga, mais leite é produzido, e isso serve para as situações de amamentação*

de gêmeos. No entanto, para garantia de uma amamentação eficiente de bebês múltiplos no maior período possível para a mulher, alguns cuidados precisam ser tomados:

- A “preparação física” das mamas (estimulação de qualquer tipo dos mamilos), que já não é mais recomendada em qualquer gestação, deve ser particularmente desaconselhada em gestações múltiplas, pelo risco de parto prematuro.
- Verificar com a gestante a possibilidade de ajuda. Ter alguém para ajudar nas tarefas de casa antes e após o nascimento de gêmeos é uma necessidade.
- Iniciar o aleitamento materno de gêmeos logo após o nascimento, sempre que possível. Se um ou mais bebês não estiverem sendo amamentados, a mãe deve iniciar a extração manual ou com bomba de sucção o quanto antes for possível.
- Haverá produção de leite suficiente para cada uma das crianças se a mãe amamentar (ou retirar leite) com frequência e em livre demanda. Orienta-se fazer o esvaziamento das mamas, no mínimo, de oito a nove vezes ao dia.
- Podem ser usadas uma das seguintes variações para amamentar os seus bebês:
 - alternância de bebês e mamas a cada mamada – muito utilizada nas primeiras semanas após o parto, especialmente se um dos bebês tem sucção menos eficiente ou quando um ou mais bebês querem mamar nas duas mamas;
 - alternância de bebês e mamas a cada 24 horas – muitas mães gostam desse método pois facilita lembrar quem mamou, onde e quando;
 - escolha de uma mama específica para cada bebê – possibilita que cada mama se adapte às necessidades de cada bebê.
- Crianças com malformações orofaciais: As malformações orofaciais mais recorrentes são: malformações de mandíbula, nariz e boca; fissura palatal; fissura labial com comprometimento das narinas e arcada dentária; fendas labiais bilaterais; dentre outras. As principais dificuldades na amamentação relatadas pelas mães de bebês com malformações orofaciais são: sucção fraca, dificuldade de pega, refluxo de leite pelas narinas, engasgos do bebê, ganho de peso insuficiente, pouco leite, ingurgitamento mamário e trauma mamilar. O aleitamento materno diminui as infecções do ouvido médio e reduz a inflamação da mucosa nasal causada por refluxo do leite, o que é muito comum nessas crianças, além de promover o equilíbrio da musculatura orofacial, favorecendo o adequado desenvolvimento das estruturas do sistema motor-oral, que estão afetadas nessas crianças. O suporte emocional e o apoio às mães, bebês e suas famílias é fundamental para a promoção da amamentação dos bebês que nascem com alguma dessas malformações. Essas dificuldades podem ser minimizadas com:
 - expressão manual do leite para amaciar mamilo e aréola; oclusão da fenda com o dedo da mãe, durante a mamada;
 - aplicação de compressas mornas nas mamas para facilitar a saída do leite; posicionamento do mamilo em direção ao lado oposto à fenda;

- *utilização da posição semi sentada para o bebê, que evita o refluxo de leite pelas narinas.*
- *Crianças portadoras de distúrbios neurológicos: Dificuldades na deglutição e na sucção, sem coordenação motora oral, refluxo gastroesofágico, com dificuldade para aceitar a alimentação, gerando risco de se desnutrirem, são sintomas apresentados por bebês que sofrem de algum tipo de distúrbio neurológico, como a asfixia perinatal grave, ou portadores de síndromes genéticas, com diversos tipos de infecções congênitas e malformações do sistema nervoso central. Nesses casos, quando a criança tem dificuldade para sugar a mama ou tem sucção fraca, deve-se:*
 - *extrair o leite com frequência;*
 - *estimular a região perioral da criança e incentivar a sucção introduzindo o dedo mínimo na sua cavidade oral;*
 - *se a criança estabelecer coordenação entre sucção, deglutição e respiração, a mãe pode oferecer cuidadosamente o peito, mas, inicialmente, com acompanhamento profissional.*

Seção 13: Cuidados com a saúde da mulher

- **Conteúdo da Seção:** *Esse conteúdo pode ser encontrado a partir da página 58 do guia completo. Um dos pontos de atenção para o sucesso da amamentação é o cuidado com a saúde da mulher que amamenta. Familiares, rede de apoio e as(os) Conselheiras(os) da Amamentação podem seguir as orientações abaixo para promover o cuidado com a saúde da mulher:*
 - *Cuidar da saúde física e mental da mulher, com incentivo à adoção de uma alimentação saudável, ingerindo alimentos naturais e menos processados. É importante ter sensibilidade e atenção ao contexto social em que cada mulher está inserida, já que situações como desemprego, baixa renda, número de membros na família, podem impactar nas condições de alimentação que a mãe terá durante a amamentação. Em casos de vulnerabilidade social, é importante orientar ou encaminhar a família para órgãos de assistência social.*
 - *Durante a amamentação, a mulher costuma sentir muita sede. É importante estar atento e incentivá-la a beber água com frequência e oferecer líquidos.*
 - *O descanso da mãe é fundamental para que ela consiga produzir leite. Para isso, é preciso dividir os cuidados com o bebê, as responsabilidades com as outras crianças da família (se houver) e as tarefas domésticas, inclusive aquelas relacionadas à alimentação.*
 - *Mães que fazem uso da substituição adequada da amamentação também precisam do apoio da família e dos amigos.*

Seção 14: Rede de apoio

- **Conteúdo da Seção:** *Esse conteúdo pode ser encontrado a partir da página 59 do guia completo. Ter uma rede de apoio pode contribuir de forma significativa para o sucesso da amamentação. O pai da criança, o companheiro ou a companheira, mãe,*

avós, amigos, profissionais de saúde, assim como as(os) conselheiras(os) da amamentação, podem dar o suporte emocional, social, físico e financeiro que a mulher precisa para seguir com a amamentação. Confira algumas dicas de como a rede pode apoiar as mães durante a amamentação:

- acompanhar as mães nas consultas de pré-natal, parto e pós-parto ajudará a mulher a se sentir apoiada e os pais e avós a se sentirem inseridos no processo;
- estimular que o(a) companheiro(a) e os filhos maiores participem do momento da amamentação, estando perto, incentivando e apoiando a mãe nos momentos difíceis e, também, nos agradáveis;
- a família pode encorajar a mãe a amamentar, mas respeitando a decisão final, que é dela; ajudar nas tarefas domésticas, no cuidado dos outros filhos menores, é um papel fundamental dos familiares;
- escutar e conversar com a mãe nos momentos de estresse e angústia é uma atitude simples e muito importante a ser desempenhada pelos familiares, amigos e outros membros de sua rede de apoio.

Seção 14: Formulário de acompanhamento domiciliar do aleitamento materno

- **Conteúdo da Seção:** Esse conteúdo pode ser encontrado a partir da página 62 do guia completo. Este instrumento permitirá a identificação do perfil socioeconômico, histórico de amamentação, demandas iniciais, dentre outras questões relacionadas às mulheres que estão amamentando e sendo acompanhadas pelas(os) Conselheiras(os).

Seção 15: Como avaliar uma mamada

- **Conteúdo da Seção:** Esse conteúdo pode ser encontrado a partir da página 67 do guia completo. O Formulário de avaliação da mamada é um instrumento de checagem que apoiará as(os) Conselheiras(os) a identificarem uma mamada eficaz. As respostas às questões apresentadas pelo formulário ajudarão na observação dos pontos de êxito e daqueles que precisam de maior atenção no processo de amamentação. Preste atenção em: sinais de que a amamentação está indo bem e sinais de possíveis dificuldades. É importante estar atenta ao bebê, a mãe, ao aspecto das mamas, a posição do bebê, a pega do bebê e a maneira como ele realiza sucção.

Seção 16: Referências do Guia de Conselheiras da amamentação

- **Conteúdo da Seção:** Esse conteúdo pode ser encontrado a partir da página 74 do guia completo.

DAMIÃO, Jorginete S.; ROTENBERG, Sheila. Amamentação e trabalho feminino: responsabilidade de toda a sociedade. Observatório Brasileiro de Hábitos Alimentares, FIOCRUZ, Brasília, 2020. Disponível em:
<https://www.arca.fiocruz.br/bitstream/handle/icict/47215/Amamenta%c3%a7%c3%a3o%20e%20trabalho%20feminino.pdf?sequence=2&isAllowed=y>

VICTORA, Cesar G. et al. *Amamentação no século XXI: epidemiologia, mecanismos e efeitos ao longo da vida*. Epidemiologia e Serviços de Saúde, Brasília, 2016. Disponível em: <http://scielo.iec.gov.br/pdf/ess/v25n1/Amamentacao1.pdf>

BRAGA, Milayde S. et al. *The Benefits of Breastfeeding for Child Development*. Brazilian Journal of Development, Curitiba, v. 6, n. 9, p. 70250-70260, set. 2020.

BRASIL. Ministério da Saúde. *Guia Alimentar para Crianças Brasileiras menores de dois anos. Versão resumida*. Brasília: Ministério da Saúde, 2021. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_alimentar_crianca_brasileira_versao_resumida.pdf

PEDRO, Carina C. L.; TORLYAMA, Aurea T. M. *A influência da amamentação no desenvolvimento emocional infantil: percepções maternas*. Revista da Sociedade Brasileira de Enfermeiros Pediatras, São Paulo, v. 18, n. 2, p. 103-108, 2018.

FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA. *Iniciativa Hospital Amigo da Criança: revista, atualizada e ampliada para o cuidado integrado. Módulo 3: Promovendo e incentivando a amamentação em um Hospital Amigo da Criança: curso de 20 horas para equipes de maternidade*. Fundo das Nações Unidas para a Infância, Organização Mundial da Saúde. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009. Disponível em: <https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/biblioteca/ihac-modulo-3-promovendo-e-incentivando-a-amamentacao/>

LOPEZ, Mariana B.; ARAN FILIPPETTI, Vanessa; RICHAUD, María Cristina. *Empatia: desde a percepção automática até os processos controlados*. Avances en Psicología Latinoamericana, v. 32, n. 1, p. 37-51, 2014.

SANTOS, Antonio Eduardo Vieira dos. *O preceptor e a relação com os principais atores do processo de ensino-aprendizagem. Unidade 3. Curso de Formação de Preceptores da Educação em Saúde – FORPRES. Módulo 1: O EU preceptor no contexto da educação em saúde*. Brasília: DDES/MEC; São Luís: DTED/UFMA, 2023.

MUFATO, L. F.; GAÍVA, M. A. M. *Empatia em saúde: revisão integrativa*. Revista de Enfermagem do Centro-Oeste Mineiro, v. 9, 2019.

HOJAT, Mohammadreza et al. *Empatia dos médicos e resultados clínicos para pacientes diabéticos*. Academia de Medicina, v. 86, n. 3, p. 359-364, mar. 2011.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. *Saúde da Criança: aleitamento materno e alimentação complementar. Cadernos de Atenção Básica*, Brasília, n. 23, 2015. Disponível em: <https://aps.saude.gov.br/biblioteca/visualizar/MTE5OQ==>

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Promovendo o Aleitamento Materno. Álbum Seriado. 2a. ed. revisada. Brasília, 2007. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/album_seriado_aleitamento_materno.pdf

FILIPIN, Monica Aparecida Gomes et al. Simbologia, manejo clínico e rede de apoio sobreintercorrências mamárias: manual educativo. Ilhéus: UESC, 2022.

BRASIL. Universidade Federal de Santa Catarina. Promoção do Aleitamento Materno na Atenção Básica. Série Formação para a Atenção Básica. Florianópolis. 2016. Disponível em: https://ares.unasus.gov.br/acervo/bitstream/ARES/13955/1/ALEITAMENTO_LIVRO.pdf

BLAIR, Robert James R. Responding to the emotions of others: Dissociating forms of empathy through the study of typical and psychiatric populations. *Consciousness and cognition*, v.14, n. 4, p. 698-718, 2005.

BRASIL. Ministério da Saúde. Glossário temático: Gestão do trabalho e da educação na saúde [Internet]. 2a. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde. Departamento de Gestão da Educação em Saúde. Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n. 1.996, de 20 de agosto de 2007. Dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente em Saúde [Internet]. Portaria n. 1.996, 20 de agosto de 2007.

CECCIM, Ricardo Burg. Educação permanente em saúde: desafio ambicioso e necessário. *Interface-comunicação, saúde, educação*, v. 9, p. 161-168, 2005.

COSTA, Fabrício Donizete da; AZEVEDO, Renata Cruz Soares de. Empatia, relação médico paciente e formação em medicina: um olhar qualitativo. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 34, p. 261-269, 2010.

DAVIS, Carol M. What is empathy, and can empathy be taught?. *Physical therapy*, v. 70, n. 11, p. 707-711, 1990.

Respostas Padrão e Respostas Não autorizadas

Exemplo de Respostas Padrão para o Chatbot:

1. Pergunta: Amamentar é um processo natural?

- **Resposta Padrão:** Amamentar nem sempre é fácil. Pode ser doloroso, cansativo e frustrante para algumas mulheres, quando não possuem rede de apoio ou ajuda de profissionais capacitados. Apesar de ser biologicamente

determinado que os seres humanos, por serem mamíferos, produzam o leite específico para o crescimento e desenvolvimento de seus filhos, a amamentação em nossa espécie não é inata, é um processo que exige conhecimento e apoio. Além de ser muito influenciada por questões sociais, sua prática requer paciência, informação e apoio para que transcorra de forma agradável.

2. Pergunta: Amamentar é fácil?

- **Resposta Padrão:** Amamentar nem sempre é fácil. Pode ser doloroso, cansativo e frustrante para algumas mulheres, quando não possuem rede de apoio ou ajuda de profissionais capacitados. Apesar de ser biologicamente determinado que os seres humanos, por serem mamíferos, produzam o leite específico para o crescimento e desenvolvimento de seus filhos, a amamentação em nossa espécie não é inata, é um processo que exige conhecimento e apoio. Além de ser muito influenciada por questões sociais, sua prática requer paciência, informação e apoio para que transcorra de forma agradável.

3. Pergunta: Quando eu sei que o leite materno é ou está fraco?

- **Resposta Padrão:** Não existe leite fraco. O leite materno tem todas as substâncias na quantidade certa que o bebê precisa para crescer e se desenvolver sadio. O leite do início da mamada contém mais água, menos gordura, grande quantidade de fatores de defesa e mata a sede. Contém também mais vitaminas e sais minerais. O leite do fim da mamada tem mais gordura e engorda o bebê. O bebê precisa do leite do começo e do fim da mamada.

4. Pergunta: Mãe que está amamentando não pode trabalhar fora?

- **Resposta Padrão:** Não é verdade. A mãe pode dar de mamar nos períodos em que estiver em casa. Pode retirar e guardar seu leite para ser oferecido ao bebê enquanto ela estiver fora.

5. Pergunta: Criança que arrotou mamando faz o peito inflamar ou o leite secar?

- **Resposta Padrão:** Não é verdade. Não há comprovação científica sobre esta afirmação popular.

6. Pergunta: Só o leite materno sustenta o bebê?

- **Resposta Padrão:** Nem sempre que o bebê chora é por fome. Pode estar com cólica, frio ou calor, molhado, ou simplesmente querendo carinho (colo). Lembre-se de que o choro é a única forma de o bebê se comunicar nos primeiros meses de vida. O importante é que ele esteja crescendo bem, o que é demonstrado nos gráficos de crescimento e desenvolvimento infantil da Caderneta da Criança, e urinando mais do que seis vezes a cada 24 horas.

7. Pergunta: Criança que nasceu prematura ou abaixo do peso pode mamar no peito?

- **Resposta Padrão:** Estes bebês podem ter dificuldades de sugar no início, mas são os que mais precisam da proteção do leite materno. Conforme eles crescem, sugam com maior facilidade. Se o bebê tiver dificuldade de sugar, retire o leite, coloque-o numa vasilha limpa e dê ao bebê com colher, copo ou translactação. Translactação é uma técnica utilizada para oferecer leite

quando o bebê suga o peito e não consegue retirar a quantidade de leite que necessita. Na translactação, quando o bebê estiver mamando, deve ser ajustada, na boca do bebê, uma sonda conectada a uma vasilha com leite. Essa técnica é importante para estimular a produção do leite da mãe ao mesmo tempo que o bebê está sendo alimentado com outro leite.

8. **Pergunta:** Amamentar faz os peitos caírem?

- **Resposta Padrão:** Não é verdade. A queda do peito depende de vários fatores: hereditariedade, idade, aumento de peso. A própria gravidez causa mudança na sua forma e posição.

Exemplo de Respostas de Exceção para o Chatbot:

1. **Pergunta:** Quero ver como é o Formulário de acompanhamento domiciliar do aleitamento materno?

- **Resposta:** Informações sobre o formulário de acompanhamento domiciliar do aleitamento materno devem ser solicitadas diretamente às conselheiras.

2. **Pergunta:** Quem são as pessoas atendidas pelo programa Conselheiras da Amamentação?

- **Resposta:** Informações sobre as pessoas atendidas pelo projeto são sigilosas. O escopo do Conselheiras da Amamentação hoje abrange puérperas da Santa Casa.

Anexos

Anexo A: Guia para a prática de aconselhamento à amamentação

- **Descrição do conteúdo do Anexo:** Este anexo contém o guia criado pelas conselheiras da amamentação, após a formação, como forma de orientar e facilitar o estudo e o acolhimento realizado por elas. Você pode acessar esse ebook em [<https://www.fjs.org.br/wp-content/uploads/2024/05/GUIA-AMAMENTACAO-EBOOK.pdf>].